

1. Le réseau veineux des membres inférieurs comprend un réseau superficiel et un réseau profond.	1. Vrai
2. Les veines communicantes ou perforantes relient le réseau superficiel au réseau profond.	2. Vrai
3. Le réseau superficiel draine 9/10 du sang veineux des membres inférieurs	3. Faux
4. Le sang veineux des membres inférieurs est normalement drainé de la superficie vers la profondeur.	4. Vrai
5. Le réseau veineux profond est composé des veines saphènes (grande, petite et accessoire).	5. Faux
6. Les valvules veineuses parsèment le réseau profond et le réseau superficiel mais pas les veines perforantes.	6. Faux
7. Les valvules veineuses servent à éviter le reflux du sang vers la périphérie.	7. Vrai
8. La varice est une dilatation permanente physiologique d'une veine superficielle.	8. Faux
9. L'insuffisance veineuse chronique est toujours causée par des varices.	9. Faux
10. Le réseau veineux superficiel draine 1/10 du sang veineux des membres inférieurs.	10. Vrai
11. L'insuffisance veineuse chronique est un syndrome associant des symptômes et des signes causées par une anomalie anatomique ou fonctionnelle veineuse permanente.	11. Vrai
12. L'insuffisance veineuse chronique peut être causée par une malformation congénitale.	12. Vrai

13. La prévalence de l'insuffisance veineuse chronique diminue avec l'âge.	13. Faux
14. L'insuffisance veineuse chronique affecte 25% des Européens actifs.	14. Faux
15. L'insuffisance veineuse chronique affecte plus de la moitié des retraités.	15. Vrai
16. Le réseau veineux superficiel des membres inférieurs comprend les veines fémorale et poplitée.	16. Faux
17. Les varices sont plus courantes chez les hommes que chez les femmes.	17. Faux
18. La compression par un anévrisme, les séquelles de TVP et le reflux lié à une insuffisance valvulaire sont des causes d'insuffisance veineuse chronique.	18. Vrai
19. Dans les pays industrialisés, 1 femme sur 2 a une maladie veineuse au cours de la vie.	19. Vrai
20. Environ 10% de la population souffrira un jour d'une ulcération d'origine veineuse.	20. Faux
21. La dysfonction de la pompe musculaire surale peut causer une insuffisance veineuse.	21. Vrai
22. Les varices sont 3x plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes.	22. Vrai
23. La prévalence des varices dans la population adulte varie entre 15 et 20%.	23. Faux
24. L'insuffisance veineuse chronique et la maladie variqueuse représentent près de 2% du budget des soins de santé dans les pays occidentaux.	24. Vrai
25. Le traitement des ulcères chroniques représente un budget de 50 millions de dollars par an aux USA.	25. Faux

26. L'insuffisance veineuse affecte 35% des européens actifs.	26. Vrai
27. La prévalence des varices dans la population adulte peut atteindre 30%.	27. Vrai
28. La différence de pression entre une veine du pied et l'OD en position debout augmente à la marche.	28. Faux
29. La station bipède augmente considérablement la pression veineuse dans les membres inférieurs.	29. Vrai
30. La pression hydrostatique entre une veine du pied et l'OD en position debout immobile est de 80 mmHg.	30. Vrai
31. Les valvules veineuses empêchent le flux centripète du sang lors de la contraction musculaire.	31. Faux
32. Les valvules veineuses sont situées uniquement dans le réseau veineux profond.	32. Faux
33. Le sang contenu dans la semelle veineuse est comprimé à chaque pas et déplacé vers le mollet.	33. Vrai
34. La pompe respiratoire favorise le retour veineux vers la cage thoracique à l'expiration.	34. Faux
35. L'insuffisance veineuse est spécifique de l'espèce humaine en raison de la station bipède.	35. Vrai
36. La différence de pression hydrostatique entre l'OD et le pied est de 15-30 mmHg à la marche.	36. Vrai
37. Le flux veineux dépend de la contraction des muscles jambiers au sein d'aponévroses extensibles.	37. Faux
38. L'insuffisance valvulaire primaire a toujours une composante héréditaire probable.	38. Vrai
39. La stase veineuse n'a aucun effet sur la paroi veineuse.	39. Faux
40. Le flux veineux turbulent a une action anti-oxydante et anti-inflammatoire.	40. Faux

41. L'hypertrophie de la paroi veineuse s'accompagne d'une diminution de son contenu en collagène.	41. Faux
42. La dégradation de la matrice extracellulaire est causée par les cellules musculaires lisses.	42. Faux
43. L'insuffisance veineuse secondaire est très souvent causée par des syndromes post-thrombotiques.	43. Vrai
44. L'hypoplasie ou l'agénésie des valvules ou de la VCI est une cause de l'insuffisance veineuse secondaire.	44. Vrai
45. Les tumeurs peuvent comprimer les veines et causer une insuffisance veineuse secondaire.	45. Vrai
46. Le syndrome de Cockett est une cause fréquente d'insuffisance veineuse secondaire.	46. Faux
47. Le syndrome de Cockett correspond à une compression de la veine iliaque droite par l'artère iliaque gauche.	47. Faux
48. La grossesse induit une insuffisance veineuse secondaire uniquement en raison des facteurs hormonaux.	48. Faux
49. Les sportifs ont un risque accru de développer une insuffisance veineuse secondaire.	49. Vrai
50. La pression hydrostatique dans la jambe diminue pendant la marche.	50. Vrai
51. La pompe veineuse surale est active uniquement pendant la marche.	51. Faux
52. Les altérations de la circulation veineuse peuvent être génétiques.	52. Vrai
53. Le flux veineux rétrograde et la stase veineuse ont un effet pro-inflammatoire et pro-thrombotique.	53. Vrai
54. La désorganisation des fibres d'élastine contribuent à rendre la veine plus rigide.	54. Vrai
55. L'insuffisance veineuse primaire est souvent causée par une thrombose veineuse.	55. Faux

56. La survenue d'un flux veineux turbulent peut entraîner une inflammation de la paroi veineuse.	56. Vrai
57. Les altérations de la circulation veineuse sont toujours séquellaires.	57. Faux
58. Les fistules artério-veineuses sont une cause d'insuffisance veineuse secondaire.	58. Vrai
59. Les altérations de la circulation veineuse sont toujours causées par des facteurs génétiques.	59. Faux
60. La réduction du flux veineux n'a aucun effet sur les cellules endothéliales de la paroi veineuse.	60. Faux
61. Les altérations de la circulation veineuse entraînent une extravasation de globules rouges.	61. Vrai
62. L'insuffisance valvulaire primaire ne survient jamais après une thrombose veineuse.	62. Vrai
63. L'hyperpression veineuse dans les membres inférieurs due à la station bipède disparaît à la marche.	63. Vrai
64. La contraction musculaire et les valvules veineuses génèrent un flux sanguin veineux centrifuge.	64. Faux
65. L'augmentation de pression intra-thoracique à l'inspiration facilite le retour veineux vers le cœur.	65. Faux
66. Le sang veineux ne peut se diriger que vers la cuisse lors de la contraction des muscles jambiers car les valvules préviennent le reflux sanguin dans toutes les autres directions.	66. Vrai
67. L'incontinence des veines perforantes peut causer une insuffisance veineuse.	67. Vrai
68. On propose au maximum une contention de classe II en cas d'insuffisance veineuse ou de varices.	68. Vrai
69. Le flux laminaire a une action pro-inflammatoire sur les cellules endothéliales de la paroi veineuse.	69. Faux

70. L'hypertrophie de la paroi veineuse est caractérisée par une désorganisation des cellules musculaires lisses et par une augmentation de son contenu en collagène.	70. Vrai
71. L'extravasation des globules rouges est responsable de dépôts tissulaires d'hémosidérine anti-inflammatoire.	71. Faux
72. La veine insuffisante est caractérisée par une alternance de paroi hypertrophique et atrophique.	72. Vrai
73. Les cellules inflammatoires dégradent les cellules musculaires lisses de la veine en cas d'inflammation.	73. Faux
74. La différence de pression hydrostatique entre l'OD et le pied est de 50 mmHg à la marche.	74. Faux
75. Le syndrome de Cockett provoque une insuffisance veineuse secondaire bilatérale.	75. Faux
76. L'âge et l'obésité sont des facteurs de risque d'insuffisance veineuse.	76. Vrai
77. Les antécédents de traumatismes des membres inférieurs et de TVP ou les antécédents familiaux de varices sont des facteurs de risque d'insuffisance veineuse.	77. Vrai
78. L'orthostatisme prolongé lié à certaines professions est un facteur protecteur d'insuffisance veineuse.	78. Faux
79. La grossesse et le sexe féminin en général sont des facteurs de risque d'insuffisance veineuse.	79. Vrai
80. L'exposition au soleil peut favoriser l'insuffisance veineuse par vasodilatation et fragilisation de la peau.	80. Vrai
81. Les manifestations cliniques de l'insuffisance veineuse sont souvent les mêmes pour tous les patients.	81. Faux
82. Les douleurs jambières sont typiquement aggravées par la surélévation.	82. Faux

83. L'insuffisance veineuse est caractérisée par un œdème péri-malléolaire qui diminue au cours de la journée.	83. Faux
84. Le système CEAP prend en compte la clinique, l'étiologie, le siège anatomique de la lésion et la pathogénie.	84. Vrai
85. La classification clinique du CEAP va de 1 à 5 selon la gravité des signes cliniques.	85. Faux
86. Les télangiectasies sont des varices non palpables de petit calibre.	86. Faux
87. L'œdème rétromalléolaire positionnel est caractéristique du stade C4 de la classification CEAP.	87. Faux
88. L'eczéma variqueux est une conséquence de la stase veineuse.	88. Vrai
89. L'atrophie blanche est une plaque scléro-atrophique correspondant à une zone d'ischémie cutanée.	89. Vrai
90. Les télangiectasies sont des dilatations hypodermiques des plexus veineux sous-papillaires.	90. Faux
91. Les ulcères veineux sont généralement très douloureux.	91. Faux
92. Les ulcères veineux sont souvent localisés dans la région péri-malléolaire externe.	92. Faux
93. Les manifestations de l'insuffisance veineuse vont d'une simple pesanteur jambière à des ulcères veineux.	93. Vrai
94. Les perles variqueuses sont des dilatations des veines profondes visibles à la surface de la peau.	94. Faux
95. L'insuffisance veineuse se manifeste souvent pas une sensibilité le long des veines inflammatoires dilatées.	95. Vrai
96. Une lourdeur des jambes, une fatigue et une sensation désagréable à l'orthostatisme prolongé sont les premiers symptômes de l'insuffisance veineuse.	96. Vrai

97. L'insuffisance veineuse peut provoquer des crampes musculaires nocturnes et un prurit au niveau des jambes.	97. Vrai
98. La classification C1 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets sans signe clinique visible ou palpable.	98. Faux
99. La durée médiane d'un ulcère veineux avant cicatrisation complète est de 3 mois.	99. Faux
100. Les télangiectasies sont des dilatations intradermiques des plexus veineux sous-papillaires.	100. Vrai
101. Les télangiectasies de 0,4 à 1mm ont généralement une couleur rouge.	101. Faux
102. La classification C2 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent des varices non palpables.	102. Faux
103. Les télangiectasies de 0,1 à 0,4mm ont généralement une couleur bleue.	103. Faux
104. Des varices réticulaires, de petit calibre (<3mm), hypodermiques et non palpables sont caractéristiques du stade C1 de la classification CEAP.	104. Vrai
105. La classification C3 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent des oedèmes.	105. Vrai
106. La dermatite de stase est caractérisée par des placards suintants et non prurigineux.	106. Faux
107. La dermite ocre est une manifestation de l'insuffisance veineuse causé par une hypoperfusion.	107. Faux
108. L'hypodermite est une réaction inflammatoire fibrosante du tissu sous-cutané causée par des épisodes infectieux répétés.	108. Vrai
109. L'atrophie blanche est causée par une occlusion d'artérioles du derme superficiel.	109. Vrai

110. L'eczéma variqueux est caractérisé par une peau suintante, vésiculeuse et rougeâtre.	110. Vrai
111. Les varices peuvent parfois se compliquer d'une thrombose veineuse superficielle.	111. Vrai
112. L'atrophie blanche est une plaque scléro-atrophique causée par une occlusion veineuse.	112. Faux
113. La classification C2 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent des varices sous-cutanées palpables de >3mm.	113. Vrai
114. La classification C6 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent un ulcère cicatrisé.	114. Faux
115. La classification C4 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent des troubles trophiques d'origine veineuse (dermite ocre, eczéma variqueux, hypodermite, lipodermatosclérose,...).	115. Vrai
116. La classification C1 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent des télangiectasies.	116. Vrai
117. Les signes physiques de l'insuffisance veineuse sont classés sur une échelle de gravité croissante en tenant compte de la sévérité de la dysfonction veineuse et de son ancienneté.	117. Vrai
118. L'œdème vespéral de la cheville est une manifestation tardive de l'insuffisance veineuse.	118. Faux
119. La dilatation des veines de l'arche plantaire interne et des régions malléolaires (corona phlebectatica) sont les premières manifestations de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.	119. Vrai
120. La dermite ocre est une complication trophique de la stase veineuse.	120. Vrai

121.	La dermite ocre correspond à une coloration bleutée de la peau due à des dépôts d'hémosidérine.	121. Faux
122.	La dermite ocre est la conséquence de l'hyperpression veineuse et de l'extravasation des GR.	122. Vrai
123.	La lipodermatosclérose donne aux jambes un aspect typique « en guêtre de cheval ».	123. Vrai
124.	La lipodermatosclérose correspond à une fibrose progressive du tissu sous-cutané au niveau des cuisses.	124. Faux
125.	L'eczéma variqueux correspond à des manifestations cutanées localisées en regard d'une varice.	125. Vrai
126.	L'eczéma variqueux est une dermatose non prurigineuse et érythémato-vésiculeuse en nappes/placards.	126. Faux
127.	Le siège préférentiel des ulcères variqueux est la région péri-malléolaire interne.	127. Vrai
128.	Les ulcères veineux sont le plus souvent peu douloureux.	128. Vrai
129.	Les ulcères d'origine veineuse sont à bords fibreux, suitants ou rouges et bourgeonnant sans nécrose.	129. Vrai
130.	Les varices se compliquent très souvent d'une thrombose veineuse profonde.	130. Faux
131.	Les varices des MI peuvent se rompre lors d'un traumatisme et provoquer une hémorragie.	131. Vrai
132.	L'insuffisance veineuse altère peu la qualité de vie des patients.	132. Faux
133.	La classification C5 de l'insuffisance veineuse désigne les sujets qui présentent un ulcère actif.	133. Faux
134.	La durée médiane d'un ulcère veineux avant cicatrisation complète est de 9 mois.	134. Vrai
135.	2/3 des ulcères veineux restent actifs pendant plus de 5 ans.	135. Vrai

136. Les ulcères veineux prennent énormément de temps à guérir et récidivent très fréquemment.	136. Vrai
137. L'anamnèse comprend la recherche de facteurs de risque de varices primitives et d'antécédents de thrombose veineuse profonde en cas d'insuffisance veineuse.	137. Vrai
138. L'examen clinique est souvent réalisé en position couchée pour détecter les varices.	138. Faux
139. Le test de Schwartz évalue la continence des valvules dans les veines fémorales et poplitées.	139. Faux
140. Les varices sont toujours secondaires à une thrombose veineuse profonde ou à une compression.	140. Faux
141. L'œdème péri-malléolaire est un signe spécifique de l'insuffisance veineuse.	141. Faux
142. Le bilan complémentaire de l'insuffisance veineuse inclut toujours une phlébographie.	142. Faux
143. L'échographie Doppler est utile pour confirmer le diagnostic d'insuffisance veineuse.	143. Vrai
144. Les médicaments veinotropes sont le traitement principal de l'insuffisance veineuse.	144. Faux
145. L'exercice physique permet de diminuer de 2/3 la pression veineuse.	145. Vrai
146. La contention des membres inférieurs diminue la pression tissulaire.	146. Faux
147. Les bas de contention doivent exercer une pression plus forte en proximal qu'à la cheville.	147. Faux
148. Les stations debout prolongées sont bénéfiques pour les patients atteints d'insuffisance veineuse.	148. Faux
149. Le traitement des varices est toujours chirurgical.	149. Faux

150. Les pansements adéquats sont essentiels pour traiter les ulcères variqueux.	150. Vrai
151. L'examen clinique est réalisé en position assise pour détecter les varices.	151. Faux
152. Le test de Schwartz évalue la continence des valvules dans les veines saphènes.	152. Vrai
153. Les varices sont souvent idiopathiques.	153. Vrai
154. L'œdème péri-malléolaire peut être causée par un lymphoedème ou une origine cardiaque ou rénale.	154. Vrai
155. L'examen clinique est réalisé en position debout pour détecter les varices.	155. Vrai
156. L'échographie-Doppler peut poser le diagnostic d'insuffisance veineuse de façon formelle.	156. Faux
157. Le décubitus et la surélévation des membres inférieurs sont des moyens de lutter contre la stase veineuse.	157. Vrai
158. Les bas de contention doivent exercer une pression plus forte à la cheville qu'en proximal pour éviter un effet garrot (bas de contention dégressive).	158. Vrai
159. Les douches d'eau froide matin et soir entraînent une vasoconstriction veineuse.	159. Vrai
160. Il existe un consensus clair sur le traitement des varices.	160. Faux
161. Des greffes cutanées sont parfois proposées dans le traitement des ulcères veineux.	161. Vrai
162. L'éviction des sources de chaleur est recommandée pour les personnes atteintes d'insuffisance veineuse.	162. Vrai
163. La turgescence des varices augmente si le patient réalise une manœuvre de Valsalva.	163. Vrai

164.	Le signe du flot évalue la transmission d'une onde de flux sur le trajet des veines saphènes.	164. Vrai
165.	La test de Schwartz nécessite les doigts des 2 mains pour la genèse et la transmission des percussions.	165. Vrai
166.	La transmission de l'onde de flux vers l'amont est le résultat du test du Schwartz chez le sujet sain.	166. Faux
167.	La transmission d'une onde de flux vers l'aval traduit une insuffisance valvulaire au test de Schwartz.	167. Faux
168.	L'onde de flux ne doit pas se transmettre vers le pied en l'absence d'insuffisance valvulaire.	168. Vrai
169.	La transmission d'une onde de flux vers l'amont traduit une insuffisance valvulaire au test de Schwartz.	169. Vrai
170.	La percussion des veines saphènes transmet une onde de flux vers l'aval chez le sujet sain.	170. Vrai
171.	Le diagnostic différentiel est primordial car le traitement de l'insuffisance veineuse par surélévation des jambes risque d'aggraver l'hypoperfusion des membres inférieurs en cas d'AOMI.	171. Vrai
172.	L'œdème des membres inférieurs n'est jamais idiopathique.	172. Faux
173.	L'échographie-Doppler permet de poser le diagnostic d'insuffisance veineuse de façon formelle.	173. Faux
174.	L'échographie-Doppler prend beaucoup de temps pour peu de bénéfices en cas d'insuffisance veineuse.	174. Vrai
175.	L'échographie-Doppler ne permet pas de réaliser une cartographie veineuse précise.	175. Faux
176.	Le duplex-scan est systématiquement réalisé lorsqu'une résection chirurgicale des varices est envisagée.	176. Vrai
177.	La phlébographie est un examen complémentaire non invasif.	177. Faux

178. La phlébographie n'est presque plus jamais réalisée.	178. Vrai
179. Le décubitus et la surélévation des membres inférieurs est le traitement de base des ulcères veineux.	179. Vrai
180. La marche, le vélo, l'aquagym et la natation permettent de réduire l'hypertension veineuse par activation de la pompe veineuse.	180. Vrai
181. La station assise est recommandée chez les sujets atteints d'insuffisance veineuse.	181. Faux
182. Les pieds doivent être surélevés de 20-30cm par rapport au lit durant la nuit.	182. Faux
183. Il n'est pas nécessaire de lutter contre la surcharge pondérale en cas d'insuffisance veineuse.	183. Faux
184. La contention augmente le différentiel entre la pression tissulaire et la pression capillaire.	184. Faux
185. La contention normalise le syndrome d'hyperperméabilité qui caractérise la micro-angiopathie de l'insuffisance veineuse chronique.	185. Vrai
186. La contention n'a pas d'effet sur le diamètre des varices mais diminue le reflux veineux.	186. Faux
187. Les bas de contention sans réglementation appliquent une pression d'environ 15-20 mmHg.	187. Faux
188. Les bas ordinaires pour dames sont d'environ 10 deniers et n'exerce pas de contention.	188. Vrai
189. L'action des bas de contention de classe I est définie par le nombre de deniers.	189. Faux
190. Les bas de contention de classe III appliquent une pression de >45 mmHg.	190. Faux

191. Les bas de contention de classe II appliquent une pression d'environ 20-30 mmHg.	191. Vrai
192. Les bas de contention de classe III sont conseillés en cas d'insuffisance veineuse ou de varices.	192. Faux
193. Une dysfonction de la pompe musculaire surale suffit à provoquer une insuffisance veineuse.	193. Vrai
194. Le port de talons hauts permet une bonne compression de la sole veineuse plantaire.	194. Faux
195. Les talons hauts et les mi-bas à élastiques trop serrés sont déconseillés en cas d'insuffisance veineuse.	195. Vrai
196. Les médicaments veinotropes peuvent parfois améliorer les symptômes mais sont d'un intérêt très limité.	196. Vrai
197. Diverses techniques (parfois risquées) permettent de « traiter » les varices : sclérose, échosclérose au polidocanol, ligatures étagées, saphénectomie par stripping, laser ou radiofréquence endoveineuse,...	197. Vrai
198. La saphénectomie par stripping est un traitement curatif des varices superficielles.	198. Faux
199. Tous les soignant sont aptes à réaliser les pansements d'ulcères veineux.	199. Faux
200. Les stations debout et assise prolongées sont à éviter dans la mesure du possible en cas de varices.	200. Vrai